



FACULTAD DE EDUCACIÓN INFANTIL

DEPARTAMENTO DOCENTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL

CARRERA: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN LOGOPEDIA

TRABAJO DE DIPLOMA

**LA ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO
INFANTIL EN EDUCANDOS CON TRASTORNOS EN EL LENGUAJE**

AUTOR (A): Amanda de la Caridad Martínez Santana, 4to año, plan de estudio E

TUTOR (A): Dr. C Carmen Díaz Morales. Profesor Titular UCPEJV

LA HABANA

2021

“Ninguna forma de violencia contra los niños y niñas es justificable y toda violencia es prevenible”

Kofi Atta Annan (2006)

DEDICATORIA

- 🌈 A los educandos con trastornos en el lenguaje, sus maestros y sus familias
- 🌈 A mi mamá Belkis, por ser mi **motor impulsor**, mi **ejemplo a seguir** y por ser mi **apoyo incondicional**.
- 🌈 A mi familia..., en especial a mi abuela Irma, mi papá Evenildo y mi tía Aida por **apoyarme y acompañarme**...en esta noble profesión.
- 🌈 A mis amigas María Karla, Wendy, Adrianna, Melissa, Laura y Thalía por estar a mi lado tantos años dándome los mejores consejos y **el amor más incondicional**.

AGRADECIMIENTOS

A la Revolución, por permitirnos una educación con todos y para el bien de todos.

A nuestro invicto comandante en jefe **Fidel Castro Ruz** por ser paradigma de la educación cubana.

A la casa de altos estudios y alma máter de la pedagogía cubana la **Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”** por contribuir a mi formación integral como profesional de la educación general y especial.

A mi tutora, Dr. C Carmen Díaz Morales por transmitirme pasión por la investigación, por estimularme constantemente, por ser paciente y dedicada. La confianza que depositó en mí, el estímulo constante, valiosos saberes y entrega incondicional me permitieron llegar a este momento tan importante para mí.

A mis **compañeros** de carrera, por darme su amor y enseñanzas.

A mi **amiga** de años Thalía, por aportar su granito de arena al resultado de horas de sacrificio y dedicación.

A **directivos y docentes** de la escuela especial para niños y niñas con trastornos de la comunicación y el lenguaje “Miguel Basilio Díaz Santamaría” por ofrecerme las herramientas necesarias para desarrollar esta investigación, en especial a **Lisbeth y Rosalía** por su ayuda constante y enseñarme que solo el amor engendra la maravilla.

A los **niños y las niñas** que presentan trastornos en el lenguaje, a sus **familias** que sin su colaboración y apoyo esta investigación hubiera sido imposible.

A mi **familia** por ser el motor impulsor de mi vida y creer en mis sueños.

A todos los que confiaron en mí y ayudaron a materializar mis sueños para poder desarrollar esta ardua tarea de educar.

Muchas gracias

RESUMEN

La presente investigación surge ante la necesidad de orientar a la familia para prevenir el maltrato infantil en sus hijos/as que presentan trastornos en el lenguaje, se desarrolla con el objetivo de proponer un folleto de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil de sus hijos/as que cursan el 4to año de vida en la Escuela Especial para niños y niñas con trastornos de la comunicación y el lenguaje: "Miguel Basilio Díaz Santamaría". En tal sentido se diseña un folleto de orientación familiar dirigido a su preparación para un desempeño efectivo de sus funciones en el desarrollo del lenguaje de sus hijos mediante la utilización de métodos del nivel teórico, empírico y estadístico, la propuesta se sustenta sobre los fundamentos filosóficos, biológicos, sociológicos, pedagógicos, psicológicos, didáctico, lingüístico y ha sido valorada positivamente por los especialistas consultados.

Palabras claves: orientación familiar, prevención, maltrato infantil, trastornos en el lenguaje.

SUMMARY

This research arises from the need to guide the family to prevent child abuse in their children who have language disorders, it is developed with the aim of proposing a family guidance brochure for the prevention of child abuse of their children They are in the 4th year of life at the Special School for boys and girls with communication and language disorders: "Miguel Basilio Díaz Santamaría." In this sense, a family orientation brochure is designed aimed at their preparation for an effective performance of their functions in the development of the language of their children through the use of methods of the theoretical, empirical and statistical level, the proposal is based on the philosophical foundations, biological, sociological, pedagogical, psychological, didactic, linguistic and has been positively valued by the specialists consulted.

Key words: family orientation, prevention, child abuse, language disorders.

ÍNDICE

Introducción	1
Capítulo 1. REFERENTES TEÓRICOS METODOLÓGICOS DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN EDUCANDOS CON TRASTORNOS EN EL LENGUAJE.	6
1.1 La orientación familiar	6
1.2 Consideraciones acerca de la prevención del maltrato infantil	11
1.3 Los trastornos del lenguaje. Definición y tipología	18
Capítulo 2. CONTENIDO DEL FOLLETO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN LAS FAMILIAS DE EDUCANDOS CON TRASTORNOS EN EL LENGUAJE	23
2.1 Operacionalización de la variable de la investigación. Análisis del diagnóstico inicial	23
2.2 Caracterización del estado inicial	25
2. 2.1 Valoración de los resultados del estado inicial de la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje	26
2.3 Fundamentación, estructura y funcionamiento de la propuesta de folleto de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje.	29
2.4 Valoración de los resultados de la consulta de especialista.	33
CONCLUSIONES	35
RECOMENDACIONES	36
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCION

El ser humano a lo largo de su existencia enfrenta conflictos a los que, por sí sólo, no puede darles solución. Por ello se hace necesario prestarle algún tipo de asistencia organizada; estos hechos son los que conforman el ámbito temático de la Orientación. Concretamente, esta investigación se centra en una de sus áreas de aplicación, la Orientación Familiar, específicamente para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje.

El maltrato infantil es un tema tan viejo como la sociedad misma. Este es un flagelo que se percibe en la actualidad y se manifiesta en la gran gama de variedades que lo forman. Las agencias internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) han dictado acciones para eliminar o al menos minimizar lo más posible esta situación. Se llama al comprometimiento de los líderes políticos, religiosos y sociales a establecer alianzas encaminadas a la prevención de la violencia y maltrato infantil.

Visibilizar esta problemática forma parte de la labor de prevención de las instituciones educativas. Es necesario continuar sensibilizando a los agentes educativos para que no solo identifiquen la problemática, sino que la prevean, intervengan o si es necesario la denuncien. El maestro logopeda es uno de los agentes educativos que desde su rol profesional puede hacer muchas acciones encaminadas a la prevención del maltrato infantil porque su accionar no se reduce al estudiantado, también incluye la orientación a la familia.

En el 1990 Cuba firmó la Convención sobre los Derechos del Niño que entró en vigor el 20 de septiembre de ese mismo año. En estos derechos se encuentran reflejados el derecho a la educación, cuidado y protección de la infancia de todo tipo de maltrato infantil; sin embargo, a casi 32 años de su aprobación y cumplimiento siguen aflorando tanto en el contexto nacional como internacional situaciones que denigran a la infancia.

La actual Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus 17 objetivos, visibiliza muchas de las metas que expresan los deseos de prevenir las formas de violencia y maltrato infantil. El objetivo 5 refiere “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar

a todas las mujeres y las niñas” como meta proclama eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. El objetivo 3 propone “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” y el objetivo 4 establece que para el 2030 se debe “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Cuba dentro de este marco internacional se preocupa de elaborar acciones dirigidas a erradicar todo tipo de maltrato o violencia, es por eso que en la Constitución de la República de Cuba (2019), en el título III, capítulo III, artículo 86, se establece que: “El Estado, la sociedad y las familias brindan especial protección a las niñas, niños y adolescentes y garantizan su desarrollo armónico e integral para lo cual tienen en cuenta su interés superior en las decisiones y actos que les conciernan”. Se aprecia la marcada significación que tiene proteger a este ser humano en formación, es imprescindible que se involucren todos los factores que tiene que ver con la educación de las nuevas generaciones.

Dentro de los grupos más vulnerables a sufrir maltrato están los adultos mayores, las mujeres, las personas con una discapacidad y los niños/as. Durante la incursión práctica de la investigadora como parte de la preparación como maestra logopeda se identificaron situaciones relacionadas con el maltrato infantil que se generan en el contexto de las familias, que en ocasiones ni son conscientes de que están reproduciendo patrones de violencia con los niños y niñas que tiene diagnóstico de trastornos en el lenguaje.

El estudio teórico realizado y los instrumentos aplicados permitieron identificar insuficiencias en la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje lo cual se revela en la siguiente ***situación problemática***:

- Insuficientes acciones del maestro logopeda en la orientación a las familias para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje.
- Limitadas ayudas a las familias de educandos con trastornos en el lenguaje dirigidas a la prevención del maltrato infantil.

Lo antes planteado permitió formular el siguiente **problema científico**: ¿Cómo contribuir a la orientación a las familias para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje?

En correspondencia con el problema científico de la investigación el **objetivo** es: Proponer un folleto de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje en la Escuela Especial para niños y niñas con trastornos de la comunicación y el lenguaje: “Miguel Basilio Díaz Santamaría”.

Para el estudio del problema científico de la investigación se proponen las siguientes **preguntas científicas**:

- 1- ¿Qué referentes teórico-metodológicos sustentan la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje?
- 2- ¿Cuál es el estado inicial de la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje en la Escuela Especial para niños con trastornos de la comunicación y el lenguaje: “Miguel Basilio Díaz Santamaría”?
- 3- ¿Qué particularidades debe tener el folleto de orientación familiar que contribuya a la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje?
- 4- ¿Qué resultados se obtienen con la consulta a especialistas del folleto de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en escolares con trastornos del lenguaje?

Para dar respuesta al objetivo de la investigación se proponen las siguientes **tareas de investigación**:

- 1- Análisis de los referentes teórico-metodológicos sobre la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje.
- 2- Caracterización del estado inicial de la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje en la Escuela Especial para niños y niñas con trastornos de la comunicación y el lenguaje: “Miguel Basilio Díaz Santamaría”.

3- Diseño de un folleto de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje.

4- Valoración de los resultados que se obtienen con la consulta a especialistas del folleto de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en escolares con trastornos del lenguaje.

La lógica de la investigación se sustenta en el método dialéctico-materialista como método general de la ciencia, a partir de la interrelación entre los métodos cuantitativos y cualitativos. Los métodos de investigación utilizados facilitaron la indagación en los referentes teóricos, metodológicos y prácticos para la caracterización del estado actual y diseño de la propuesta. Estos fueron:

Métodos del nivel teórico

Analítico- sintético: permitieron interpretar, procesar y sistematizar la información teórica y empírica relacionada con la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje.

Inductivo- deductivo: Posibilitó inferir y sistematizar las particularidades de la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje.

Análisis de documentos: se utilizó para la fundamentación de la prevención del maltrato infantil desde sus bases jurídicas, legales y normativas

Modelación: permitió conformar un folleto de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje.

Métodos del nivel empírico

Análisis de documentos: permitió identificar las acciones dirigidas a la orientación familiar del estudiantado con trastornos del lenguaje y constatar si se reflejan en los expedientes clínico- psicopedagógicos y logopédicos aspectos relacionados con el maltrato infantil.

Observación: permitió constatar mediante las reuniones de padres cómo se realiza la orientación familiar dirigida a la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje.

Entrevista: a los directivos de la escuela para indagar sobre cómo se concibe la orientación familiar dirigida a la prevención del maltrato infantil.

Encuesta: al profesorado y la familia para identificar sus necesidades y fortalezas en relación con la prevención del maltrato infantil.

Técnica de exploración logopédica: permitió diagnosticar a los educandos objeto de estudio.

Consulta a especialistas: permitió evaluar la propuesta.

Métodos estadísticos y/o matemáticos:

Análisis porcentual: permitió el procesamiento de los datos obtenidos con los instrumentos aplicados.

Grupo de estudio: para la investigación fueron seleccionados 9 educandos que cursan el 4to año de vida en la Escuela Especial “Miguel Basilio Díaz Santamaría” del municipio Cerro que presentan retraso del lenguaje, 8 logopedas con un aproximado entre 3 y 7 años de trabajo con los niños y niñas con trastornos de la comunicación y el lenguaje de la Escuela Especial “Miguel Basilio Díaz Santamaría” y 9 familias que sus hijos presentan retraso del lenguaje.

Actualidad:

La investigación tributa al Proyecto de Investigación: “La inclusión y atención educativa a la diversidad en la educación infantil cubana. Retos para la formación del maestro”, dirigido por la Dr.C. Zenaida Esperanza Matos Machado, profesor Titular de la Facultad de Educación Infantil de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. Se inserta en el Grupo Científico Estudiantil: “Género, Salud y Educación de la Sexualidad” y a la Cátedra de Estudios Logopédicos “Ricardo Cabanas Comas” de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La temática que se indaga aparece reflejada en el banco de problemas de la escuela seleccionada para la investigación.

CAPÍTULO I: REFERENTES TEÓRICOS- METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN LA ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN EDUCANDOS CON TRASTORNOS EN EL LENGUAJE

En el capítulo se tratan los referentes teórico- metodológicos que sustentan la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje.

1.1 La orientación familiar

La familia es objeto de estudios realizados en los campos de la psicología, la sociología y la pedagogía, reconociendo su papel crucial en el desarrollo espiritual de los niños/as. La familia es una de las instituciones básicas del desarrollo histórico de la sociedad; es considerada la más estable, continua y extendida, porque, a pesar de la adopción de diversos patrones y formas de organización durante su desarrollo y evolución, ha conservado su naturaleza y características.

En el tratamiento a la temática de familia se destacan autores como: Savater, F. (1997); Árias, G. (1998); Blanco, A. y Recarey, S. C. (1999); Freire, P. (1999); Arés, P. (2000, 2002, 2003 2011); Ibarra, L. (2005); Castro, P.L. (2010); Gómez, M. V. (2010); García, A. (2011); Torroella, G. (2011); Padrón, A.R. (2011); Collazo, B. (2011); Recarey, S.C. y Del Pino, J. L. (2011); Reinoso, A. C. (2011), y otros. Enfatizan en la necesidad de contar con recursos educativos en la preparación para la vida. Arias G. (2001) plantea que la familia como categoría histórica, social y psicológica es expresión de la unidad de lo universal, lo singular y particular, por lo que se debe analizar “con un enfoque integrador, dinámico, interactivo y evolutivo”.

Los investigadores en el tema de la familia consideran que es el grupo primario con responsabilidad directa para el desarrollo de sus miembros, y constituye un excelente espacio para el desarrollo personal. Es también el lugar donde el hombre adquiere sus primeras vivencias, valores y nociones del mundo, y le aporta las condiciones necesarias para el avance de una personalidad sana, se reconoce como el medio natural por excelencia donde se adquieren aprendizajes que actúan como estímulos en el desarrollo social.

Destaca Olga Franco García (2011) el importante rol que desempeña la familia en la formación de sus hijos, la necesidad de procurar un ambiente adecuado entre sus

miembros, donde se proporcione los elementos necesarios para lograr el bienestar y el desarrollo. Para lograr esto, es preciso que existan relaciones familiares armoniosas, caracterizadas por la comunicación, la confianza, apoyo y unión entre todos.

La labor de formar a las nuevas generaciones necesita de la integración y coherencia de todas las acciones educativas que reciben los educandos, especialmente, aquellos que se encuentran en el período que se denomina Primera Infancia. La familia y los agentes educativos deben estar preparados para realizar un proceso educativo de calidad que contribuya al fin de la educación cubana, de *lograr el máximo desarrollo integral posible en cada uno de los niños y las niñas de 0 a 6 años, lo que, al mismo tiempo, constituye un derecho*. Albite, A., Grenier, M., Rivera., Sirverio, A., Padrón, B., Pérez, M., & Valdés, M. (2021).

Refiere Dra. Patricia Arés Muzio (2002) que la familia es la instancia de intermediación entre el individuo y la sociedad. Constituye el espacio por excelencia para el desarrollo de la identidad y es el primer grupo de socialización del individuo. Es en la familia donde la persona adquiere sus primeras experiencias, valores y concepción del mundo. La familia aporta al individuo las condiciones para un desarrollo sano de la personalidad o en su defecto es la principal fuente de trastornos emocionales.

El trabajo educativo y formativo de la familia se complementa con la labor de la escuela como institución que también desarrolla una tarea de vital importancia para lograr el desarrollo integral de la personalidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que transiten por esta institución. En la escuela convergen diferentes familias, cada una con sus particularidades, historias y estilos educativos que no siempre son favorecedores para el desarrollo saludable de su descendencia.

La escuela cubana posee potencialidades para crear innumerables situaciones educativas que repercutan favorablemente en el desempeño de las familias, y de la comunidad, pero sobre todo que trasciendan en elevar la calidad de vida de las nuevas generaciones. Tanto la familia como la escuela están llamadas a entenderse, y a unirse en el cumplimiento de sus propósitos educativos, para ello se requiere el uso de recursos y materiales didácticos que faciliten la comprensión y cambios de actitudes en las familias. El personal docente debe poseer preparación que le posibilite la orientación familiar de forma sencilla, rápida y amena.

La orientación familiar ha constituido un tema de investigación para diferentes autores los cuales han ofrecido definiciones:

Según Castro, P. (2003) Define la orientación familiar como una modalidad de acción psicológica con fines educativos, constituye un proceso de ayuda o asistencia para promover el desarrollo de mecanismos personológicos por medio de la reflexión, la sensibilización y la implicación personal en la conducción de acciones educativas.

Gómez, A. (2007) en su tesis de doctorado plantea que la orientación familiar es un proceso de ayuda de carácter multidisciplinario, sistémico y sistemático dirigido a la satisfacción de las necesidades de cada uno de los miembros de las familias. Es un sistema de influencias socioeducativas encaminadas a elevar la preparación de la familia y brindar estímulo constante para la adecuada formación de su descendencia.

García, A. (2011) define la orientación familiar como una modalidad de la orientación psicológica con fines educativos, de igual manera el autor explica que es un proceso de ayuda o asistencia para promover el desarrollo de mecanismos personológicos a través de la reflexión, sensibilización y la implicación personal de sus miembros para mejorar la conducción de acciones educativas. Esta ayuda o asistencia se materializa en consejos, recomendaciones, reflexiones e instrucciones.

La orientación familiar precisa de una orientación donde el profesor propicie la relación dialéctica niño/a- familia a través de una posición reflexiva de aprendizaje, en situaciones de la vida familiar que subjetivasen la experiencia cotidiana, y orienten su regulación consciente. Toda intervención que se realice en el marco de la orientación familiar tendrá, sin lugar a duda, presente las necesidades que surjan, en la particularidad de cada grupo familiar y atenderá, siempre que sea posible, a la prevención y educación.

Los diferentes investigadores tienen puntos de coincidencia y demuestran que la orientación familiar como proceso racional parte del análisis y la reflexión para ir transformándose en actividad que coordina, agrupa, integra, sensibiliza y da forma orgánica a un conjunto de decisiones y acciones, según el contexto estudiado, en un plazo determinado, con el grupo en su situación concreta.

A partir de las definiciones ofrecidas por los autores mencionados se asume la de Torres, M. (2003) la orientación familiar es un conjunto de acciones dirigidas a la

capacitación de las familias para un desempeño efectivo en el logro de sus funciones de forma tal que garantice un crecimiento y desarrollo personal y como grupo.

Collazo Delgado, B. (1992) en el libro *La orientación en la actividad pedagógica* y Fernández Collado, C. (1989) en el libro *La comunicación humana*; resumieron algunos puntos importantes sobre la orientación familiar en el ámbito educativo y sus rasgos característicos. Determinan que la orientación familiar es un proceso continuo, gradual y progresivo en el establecimiento de determinadas relaciones hogar-escuela, que posibilita diagnosticar las problemáticas de la familia y de atenderlas sobre bases objetivas, teniendo en cuenta sus particularidades, con el fin de lograr su preparación para la realización de su labor educativa-formativa.

Rasgos de la orientación

- El carácter relacional del ser humano, de manera que no se presta atención a individuos aislados, sino en el marco de su contexto social y familiar, desde una posición interactiva.
- La necesidad de ayuda al individuo, conocerse a sí mismo y a su medio. Se destaca aquí el papel activo del sujeto en la transformación del medio en el cual se desarrolla.
- La necesidad de que se desarrolle en el individuo la capacidad de utilizar su inteligencia para tomar decisiones y aprovechar al máximo sus potencialidades, de acuerdo con las oportunidades que se ofrecen; se debe estimular la autodirección.
- El carácter sistémico, procesal y regular que debe tener el trabajo de orientación.
- La necesidad de orientación que tiene todo individuo.

En la investigación se asumen aspectos significativos que deben tenerse en cuenta al concebir el proceso de orientación familiar, el cual significa ayuda y no imposición.

- Objetividad, es decir, que la información acerca de la existencia de un problema de la familia sea detectado en visita, o por medio de la información que un instrumento aplicado aporte de manera que la orientación pueda ser efectiva.

- Legitimación. Es tener en cuenta las necesidades de los sujetos y de la solución de los problemas reales que existen.
- Contextualización. Es ubicarse en momento, época, para orientar soluciones a un problema de acuerdo a las condiciones y posibilidades del momento.
- Trabajar desde una posición positiva buscando potencialidades que tiene el sujeto para el cambio.
- Acercamiento al mundo exterior del sujeto. Solo conociendo esto, puede saberse las fortalezas y disposición de la persona a su transformación.

La orientación y la educación:

La esencia de la labor del educador es preparar al hombre para la vida, a partir del desarrollo de sus potencialidades y de la modificación de sus actitudes y concepciones. Si los docentes brindan la orientación y ayuda necesaria a la familia se podrá formar un sujeto capaz de asumir los retos que le imponen las condiciones en que se desenvuelven.

La orientación familiar es una alternativa de la educación sistemática que prepara la familia para el desempeño de sus funciones sobre todo la socializadora y permite coordinar entre las familias y los educadores las acciones educativas necesarias. Es un espacio de reflexión y debate en torno a temas de interés colectivo referentes a la educación de sus hijos encaminadas a elevar la preparación de las familias para que puedan cumplir con calidad su rol.

Según Collazo Delgado (1992); el radio de acción del ámbito de la orientación familiar toma en cuenta tres posibles finalidades:

- Prevención: no es más que el medio de prevención de conflictos intrafamiliares, al mostrar a la familia la forma de construir una sana interacción. La intervención se da a nivel educativo, por lo que el profesional no analiza la interacción propia de una familia. Al considerar a la familia como uno de los núcleos principales para el desarrollo personal y social de cada uno de sus miembros, es necesario dar a conocer las formas más adecuadas de comunicarse e interrelacionar entre sus componentes, así como las etapas de desarrollo que atraviesa tanto personalmente como de manera familiar.

- Asesoramiento: es un nivel más complejo en el que no podemos limitarnos a informar, sino que, dados los obstáculos del dinamismo familiar y de la evolución de cada uno de sus miembros, las intervenciones van dirigidas a trazar líneas más adecuadas de convivencia y comunicación que permitan solventarlos.
- Tratamiento terapéutico: este nivel permite el conocimiento de la interacción familiar que haga el profesional como elemento fundamental, ya que tendrá que ilustrar los cambios y las posibles estrategias para conseguir romper el dinamismo que están paralizando el sano crecimiento de todo el sistema familiar.

Se asume en la investigación las tres posibles finalidades descritas anteriormente, pero centrando la orientación familiar a la prevención del maltrato infantil que a consideración de la investigadora es un penoso fenómeno social que la escuela esta invocada a prevenir.

1.2 Consideraciones acerca de la prevención del maltrato infantil

Por su significación en el proceso de formación de la personalidad de los escolares, en Cuba, la prevención se trata por diferentes autores como Torres, M. (2003); Betancourt, J y González, O. (2005); López, R. (2006); Briñas, J. (2007); Ortega, L. (2009) quienes, entre otros especialistas, han realizado importantes contribuciones al trabajo preventivo en la Educación Especial. Todos coinciden en ponderar su carácter anticipatorio y procesal, como parte del proceso educativo dirigido al desarrollo integral de la personalidad del niño/a.

Al respecto Betancourt, J y González, O. (2005), destacan que la prevención es una dimensión de la acción educativa que implica la actuación oportuna de los agentes de socialización para promover el desarrollo y estimular potencialidades. Las autoras implican en la prevención a todas las entidades educativas en las que el niño/a desarrolla su vida, lo que enfatiza el papel de la escuela, la familia y la comunidad, como potenciadores del desarrollo.

Así mismo, Briñas, J. (2007) en su tesis doctoral, reflexiona sobre la prevención con un enfoque integral, transformador, orientado a estimular las potencialidades, donde desempeñan un papel importante las iniciativas preventivas en el proceso docente educativo a partir de la participación del colectivo pedagógico.

En consonancia con estos criterios, Rodney, Y afirma: “la prevención es un proceso, de naturaleza educativa, lo que no puede quedar sin declararse; porque implica anticiparse a lo que puede suceder en el futuro y preparar condiciones tanto humanas como materiales para alcanzar una mejor calidad de vida en cualquier esfera y garantizar la reproducción efectiva de las relaciones sociales, estables y armónicas de la sociedad” (Rodney, Y. 2010:37).

A partir del estudio teórico se destaca el papel de todos los factores sociales en la labor preventiva, pero se resalta al profesional de la educación. En esta investigación se quiere destacar el rol del maestro logopeda. Este especialista tiende a trabajar con grupos pequeños, lo que facilita poder adentrarse en las interioridades de las familias de sus escolares e identificar situaciones de riesgo, como puede ser la violencia o maltrato que sufren los niños/as que presentan trastornos en el lenguaje.

Para UNICEF (1990), las víctimas del maltrato infantil y el abandono pertenecen al segmento de la población conformada por niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, en el grupo familiar o en las instituciones sociales. Esta organización reconoce el gran reto y la difícil tarea que asumen diariamente las madres, padres y cuidadores y les invita a afrontar el desafío de construir nuevos procesos de crianza basados en el diálogo con el propósito de formar niños y niñas más felices y plenos, que se conviertan en ciudadanos más participativos, con capacidad de reflexión, autogestión y liderazgo.

En 1999, la Reunión de Consulta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Prevención del Maltrato de Menores redactó la siguiente definición: “El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño/a, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.”

Según se recoge en el artículo 9 de la convención sobre los Derechos del niño de Naciones Unidas (2006) “todo niño o niña tiene derecho a vivir y desarrollarse sin sufrir ninguna forma de violencia, abuso o maltrato, y es responsabilidad de los adultos que les rodean, especialmente sus familias y sus maestros, así como del

estado donde viven, garantizarles la oportunidad de aprender a amar y ser amados sin sufrir alguna forma de violencia.”

De dicha convención del Niño, su artículo 19 refiere que el maltrato infantil “es toda forma de perjuicio o de abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño/a se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

Cuando se hace referencia al maltrato infantil en el ámbito familiar, se indica que quienes infringen violencia contra los niños, niñas y adolescentes son sus familiares en primer grado, es decir sus padres, madres, abuelos/as, hermanos/as, y tíos/as, principalmente. (Larraín y Bascuñán, 2006).

Si bien existen varias definiciones de maltrato infantil, en esta investigación se asume la adoptada por la Organización Panamericana de la Salud (2003). La misma lo conceptualiza como “toda forma de abuso físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, que produzca daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño y la niña, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o de poder”.

El maltrato infantil atenta contra los derechos más básicos de niños, niñas y adolescentes, es un problema que afecta a la sociedad en general, perjudicando el contexto familiar, escolar y comunitario. Dejando irreparables huellas que marcan el desarrollo de la personalidad.

El maltrato, tanto a niños, niñas, como a adolescentes, es hoy una realidad frecuente. Cuando se habla de maltrato infantil se suele pensar en situaciones muy graves y crueles. Se oyen en los medios de comunicación noticias de malos tratos aberrantes, que repugnan. Sin embargo, existen otras formas de maltrato, muchas que no tienen que ver con las secuelas físicas o el abuso sexual y, por ello, son más difíciles de identificar. Pero son más frecuentes y con efectos devastadores para el niño o niña.

Existen diferentes tipos de maltrato infantil, los cuales son:

El maltrato físico, este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados utilizando la fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es decir, es aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionados por adultos (padres, madres, tutores,

maestros, etc.) que originan en el niño/a un daño físico o enfermedad. Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, etc.

La negligencia infantil o abandono, es una falta de responsabilidad parental que ocasiona una omisión ante aquellas necesidades del niño/a para su supervivencia que no son satisfechas temporal o permanentemente por los padres, madres, cuidadores o tutores. Comprende una vigilancia deficiente, descuido, privación de alientos, incumplimiento de tratamiento médico, impedimento a la educación, etc.

El maltrato emocional, es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas que amenazan el normal desarrollo psicológico del niño/a. Estas conductas comprenden insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, toda clase de hostilidad verbal hacia el niño/a. Este tipo de maltrato infantil ocasiona que en los primeros años del niño/a, este no pueda desarrollar adecuadamente el apego y, en los años posteriores, se sienta excluido del ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus habilidades sociales.

El abuso sexual, es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la hora de estudiar. Consiste en aquellas relaciones sexuales que mantiene un niño o una niña (menor de 18 años) con un adulto o con un niño/a de más edad, para las que no está preparado evolutivamente y en las cuales se establece una relación de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima.

Las formas más comunes de abuso sexual son: el incesto, la violación, la vejación y la explotación sexual. También incluye la solicitud indecente sin contacto físico o seducción verbal explícita, la realización de acto sexual o masturbación en presencia de un niño/a y la exposición de órganos sexuales a un niño/a. El maltratador habitualmente es un hombre (padre, padrastro, otro familiar, compañero sentimental de la madre u otro varón conocido de la familia), raramente es la madre, cuidadora u otra mujer conocida por el niño/a.

Síndrome de Munchausen por poderes, otro tipo de violencia infantil, que consiste en inventar una enfermedad en el niño/a o producirla por la administración de sustancias y medicamentos no prescritos. Generalmente, se trata de un niño/a en la edad de lactante- preescolar (edad media de 3 años). Los signos y síntomas aparecen

solamente en presencia de la madre (habitualmente, el perpetrador del abuso) son de causa inexplicables y los exámenes complementarios no aclaran el diagnóstico.

Maltrato prenatal, definido como aquellas circunstancias de vida de la madre, siempre que exista voluntariedad o negligencia, que influyen negativa y patológicamente en el embarazo, parto y repercuten en el feto. Tales como: rechazo del embarazo, falta de control y seguimiento médico del embarazo, negligencia personal en la alimentación e higiene, medicaciones excesivas o no prescritas, consumo de alcohol, drogas y tabaco, exposición a radiaciones y otras.

Maltrato institucional, consiste en cualquier legislación, programa o procedimiento, ya sea por acción o por omisión, procedente de poderes públicos o privados, por profesionales al amparo de la institución, que vulnere los derechos básicos del menor, con o sin contacto directo con el niño/a.

La disminución de los factores compensatorios explica la espiral de violencia intrafamiliar que se produce del maltrato infantil. Entre los factores compensatorios se señalan: armonía marital, planificación familiar, satisfacción personal, escasos sucesos vitales estresantes, intervenciones terapéuticas familiares, apego materno/paterno al hijo, apoyo social, buena condición financiera y acceso a programas sanitarios adecuados. Entre los factores estresores se cuentan: historia familiar de abuso, desarmonía familiar, baja autoestima, trastornos físicos y psíquicos en la familia, farmacodependencia, hijos no deseados, padre no biológico, madre no protectora, ausencia de control prenatal, desempleo, bajo nivel social y económico y la promiscuidad.

En el artículo *Protocolo contra el maltrato infantil. Observatorio de la infancia. (2007)* se explica con detalle las consecuencias del maltrato infantil:

Independientemente de las secuelas físicas que desencadena directamente la agresión producida por el abuso físico o sexual, todos los tipos de maltrato infantil dan lugar a trastornos conductuales, emocionales y sociales. La importancia, severidad y cronicidad de estas secuelas depende de:

- intensidad y frecuencia del maltrato;
- características del niño/a (edad, sexo, susceptibilidad, temperamento, habilidades sociales, etc.);

- el uso o no de la violencia física;
- relación del niño/a con el agresor;
- apoyo intrafamiliar a la víctima infantil;
- acceso y competencia de los servicios de ayuda médica, psicológica y social.

En los primeros momentos del desarrollo evolutivo, se observan repercusiones negativas en las capacidades relacionales de apego y en la autoestima del niño/a, así como pesadillas y problemas del sueño, cambios de hábitos de comida, pérdidas del control de esfínteres, deficiencias psicomotoras y trastornos psicosomáticos. En escolares y adolescentes se encuentran: fugas del hogar, conductas autolesivas, hiperactividad o aislamiento, bajo rendimiento académico, deficiencias intelectuales, fracaso escolar, trastorno disociativo de identidad, delincuencia juvenil, consumo de drogas y alcohol, miedo generalizado, depresión, rechazo al propio cuerpo, culpa y vergüenza, agresividad, problemas de relación interpersonal.

Los maestros, al ser los profesionales de la educación y que están en mayor contacto con los niños/as, son los llamados a realizar la prevención del maltrato infantil. Estos se encuentran en una posición favorable para detectar niños/as en situación de riesgo (sobre todo en menores de 5 años, la población más vulnerable), a partir de esta edad los educadores comienzan a tener un papel principal en la prevención y diagnóstico del maltrato en niños/as.

Según la *Guía para padres y madres. Prevención y abordaje del maltrato infantil y abuso sexual desde la familia y las AMPAS (2015)*, la prevención del maltrato infantil se establece en tres niveles:

1. Prevención primaria: Dirigida a la población general con el objetivo de evitar la presencia de factores estresores o de riesgo y potenciar los factores protectores del maltrato infantil: Se incluyen:
 - Sensibilización y formación de profesionales de atención al menor
 - Intervenir en la psicoprofilaxis obstétrica (preparación al parto)
 - Intervenir en las escuelas para padres, promoviendo valores de estima hacia la infancia, la mujer y la paternidad.
 - Prevenir el embarazo no deseado, principalmente, en mujeres jóvenes, mediante la educación sexual en centros escolares.

- Búsqueda sistemática de factores de riesgo en las consultas de niño/a sano, así como evaluar la calidad del vínculo afectivo familia-hijos, los cuidados del niño/a, actitud de las madres y padres en la aplicación del binomio autoridad-afecto.
 - Intervenir en las consultas y exponer los derechos de los niños/as y la inconveniencia de los castigos físicos. Ofrecer la alternativa de la aplicación del castigo conductual.
 - Identificar los valores y fortalezas de la familia, reforzando su autoestima.
2. Prevención secundaria: Dirigida a la población de riesgo con el objetivo de realizar un diagnóstico temprano de la violencia infantil y un tratamiento inmediato. Atenuar los factores de riesgo presentes y potenciar los factores protectores. Se incluyen:
- Reconocer situaciones de maltrato infantil, estableciendo estrategias de tratamiento.
 - Reconocer situaciones de violencia infantil, doméstica o de abuso a la mujer y buscar soluciones.
 - Reconocer las conductas paternas de maltrato físico o emocional, considerando la remisión de la familia a una ayuda especializada en el manejo de la ira y la frustración.
 - Remitir a centros de salud mental a familiares con adicción al alcohol y drogas.
3. Prevención terciaria: Consiste en la rehabilitación del maltrato infantil, tanto para las víctimas como para los maltratadores. Para ellos, se debe disponer de un equipo interdisciplinario (pediatras, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, orientadores, familiares, terapeutas, jueces de menores, cuerpos policiales, etc.)

El maltrato infantil tiene muchas formas más o menos encubiertas, pero en todas las formas hay abuso por parte del adulto contra un ser más pequeño e indefenso. También se produce un aprendizaje negativo pues los niños/as se identifican con sus agresores para repetir, posteriormente, con amigos y futura familia, sus conductas. El maltrato infantil y la violencia familiar en general llevan incondicionalmente a

trastornos psicológicos infantiles y por tanto puede provocar también trastornos del lenguaje.

1.3 Los trastornos del lenguaje. Definición y tipología

El lenguaje es un instrumento básico para la relación interpersonal; es un acto de comunicación que permite intercambiar ideas y emociones. Se halla estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento ya que para llegar al lenguaje se tiene que imaginar y recordar, tener el símbolo de las cosas sin que estas estén delante.

En el campo de la logopedia, la problemática de los trastornos del lenguaje es muy amplia y variada, proceden de diversos orígenes y grados de severidad, unos tienen un pronóstico más favorable como es el caso de la dislalia, que constituye un trastorno de la articulación donde se altera la pronunciación de los fonemas del idioma, su carácter puede ser fonético o fonético- fonemático. Los trastornos de la comunicación y el lenguaje afectan gravemente la manera en que las personas utilizan y procesan el lenguaje.

El hecho de que los trastornos del lenguaje son diversos por su etiología y estructura, exige la utilización de una variedad de métodos y procedimientos para el trabajo correctivo en la práctica logopédica, según la naturaleza y las formas de manifestación de cada uno. En este proceso se debe considerar la influencia de varios factores desde una concepción dinámica que tenga en cuenta la relación causa-efecto. Por eso, es necesario agruparlos a partir de diferentes criterios, como resultado del desarrollo de las ciencias en cada momento histórico concreto.

El empleo de una clasificación funcional es muy importante para la evaluación, caracterización y diagnóstico explicativo y diferencial del trastorno del lenguaje. En virtud de la intervención logopédica ajustada a las demandas educativas de los educandos y su entorno escolar, familiar y comunitario.

Es pertinente reconocer la necesidad de agrupar y/o clasificar los trastornos del lenguaje para ofrecer una atención logopédica que satisfaga las carencias y potencie el desarrollo de los niños/as; por el amplio campo de acción que abarca esta ciencia, en su interrelación con otras ciencias, tanto médicas como de la educación. Además, por el hecho de considerar el carácter impredecible del discurso fundamentado en la teoría de la complejidad.

En este sentido, se habla del lenguaje como un objeto complejo. Roméu, A., (2007). En el que se consideren diferentes factores que confluyen por el carácter multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar de la logopedia, la que trasciende a otros campos de investigación y no solo de determinados criterios que restringen su objeto de estudio.

Los trastornos del lenguaje se clasifican en diferentes tipos: trastornos en la comunicación oral y trastornos en la comunicación escrita.

En la comunicación oral se encuentran los trastornos del nivel habla, voz y lenguaje.

Los trastornos del habla se producen cuando se presentan alteraciones en las normas adoptadas por la generalidad de un idioma dado, a partir de su uso por una comunidad lingüística determinada. Las alteraciones en la pronunciación de los sonidos se presentan en forma de: omisión, sustitución, distorsión, adición, fundamentalmente.

Trastornos del habla que comprometen el componente articulatorio: Dislalia, Rinolalia y Disartria.

Dislalia: su origen es griego (dis: dificultad y lalia: hablar) Se refiere a los trastornos de pronunciación que se presentan sin otra manifestación acompañante, y en presencia de una audición normal. E. Figueredo y otros. Log.1

Rinolalia: Término que proviene del griego (rhino- nariz y lalia- hablar) Es un trastorno del habla donde se afecta la pronunciación de los sonidos verbales y se acompaña de la alteración del timbre de la voz (hiponasalidad o hipernasalidad), se dificulta el equilibrio entre la resonancia nasal y bucal.

Disartria: el término proviene del griego (dis- dificultad y arthron- articulación) Es un trastorno orgánico del lenguaje, de carácter neurológico, debido a lesiones en regiones centrales y en las vías conductoras del sistema motor verbal, hay una insuficiente inervación de los órganos que intervienen en la omisión del habla, se afecta severamente el componente sonoro del lenguaje y el aspecto léxico- gramatical de la lengua.

Trastornos del habla que comprometen el componente ritmo- fluidez: tartamudez y tartaleo.

Tartamudez: Trastorno complejo de la comunicación oral caracterizado por espasmos que interrumpen la fluidez verbal, acompañado de síntomas orales y psicopatológicos, de naturaleza multicausal, al afectarse los mecanismos de control del habla, la comunicación y la personalidad.

Tartaleo: Trastorno de la comunicación oral de carácter heredo- constitucional, central que se manifiesta generalmente en la emisión rápida y atropellada del lenguaje y la consiguiente alteración de la fluidez verbal, de la estructuración fónica y silábica de las palabras que provocan alteraciones en la estructura de la frase y dificultan la comprensión del lenguaje por parte del interlocutor.

Los trastornos del nivel voz comprenden: las disfonías, tonopatías y rinofonías.

Voz: es un sonido laríngeo que según sus matices expresa el estado emocional de las personas y constituye el soporte físico para el habla y la comunicación donde la cualidad timbre es un atributo individual y singular irrepetible que nos distingue.

Disfonías: Constituyen alteraciones del timbre que se caracterizan por ronquera, velamientos de la voz, cansancio o fatiga vocal y se dividen en funcionales y orgánicas.

- Disfonías funcionales: Roy (2003) y Seifert (2005) Deterioro del sonido de la voz y/o una reducción en la capacidad vocal, con un diagnóstico concomitante posible de enfermedades menores de la cubierta de las cuerdas vocales (nódulos, pólipos, edema) que son resultado directo de un mal uso vocal o resultado de traumas causados a los tejidos de las cuerdas vocales por el comportamiento fonatorio.
- Disfonías orgánicas: Trastorno de la voz producto de una alteración anatomofisiológica de las cuerdas vocales, que puede ser intralaringea congénita o adquirida o extralaringea.

Tonopatías: Son los trastornos causados por una evolución no satisfactoria de la muda de la voz. Entre los trastornos tonales funcionales precoces se distinguen la voz sobreaguda (voz de falsete), la voz ultragrave (tonalidad vocal marcadamente grave) y la voz alternante o rajada (cambios bruscos entre registros agudos y graves). Los trastornos tardíos agrupan una serie de síntomas de debilidad fonatoria persistente que constituyen la fonastenia.

Rinofonías: En los trastornos de la resonancia se describe la hiperrinofonía (exceso de resonancia nasal) que se debe a factores orgánicos y funcionales. Los primeros se ponen de manifiesto cuando existe una alteración en la constitución anatómica del paladar duro o blando tales como fisura palatina submucosa y afecciones neurológicas. Los factores funcionales se evidencian en caso de mal funcionamiento del velo que no permite su cierre al paso de los sonidos no nasales y por tanto aparece la nasalización de los mismos, siendo frecuente esta Hiperrinofonía por imitación y descuido.

Trastornos del nivel comunicativo lenguaje: Retraso del lenguaje, afasia y disfasia.

Retraso del lenguaje: debe considerarse a un niño/a con retraso en el lenguaje cuando lo cuantitativo y lo cualitativo de su uso verbal se halle por debajo de la cifra media de los niños/as de su edad, es decir, si un niño/a continúa dependiendo de gestos para comunicarse cuando ya debiera estar utilizando signos convencionales verbales; pero aun utilizando palabras lo hace de una manera tan deformada en su articulación, que es ininteligible su lenguaje y solo utiliza determinados elementos gramaticales, tanto los aspectos sintáctico, léxico y pragmático, demorándose en la adquisición de otros nuevos elementos lingüísticos Álvarez, L.(2008)

Otra definición toma en consideración que es un “[...] trastorno del lenguaje que afecta la formación y desarrollo de sus componentes estructurales (fonología, semántica, sintaxis) relacionados con los mecanismos de recepción y programación lingüística” X. Rodríguez y M. L. Díaz, (2008)

Por otra parte, se considera que un niño/a está retrasado en el lenguaje cuando desde el punto de vista cuantitativo (cantidad de vocabulario) o cualitativo (diferentes áreas del lenguaje) está por debajo de la cifra media de los niños/as de su edad López, M. (1997).

Afasia: se define la afasia como las alteraciones del habla y del lenguaje asociadas a lesión cerebral. Echávarri, C, (2000).

La afasia es una pérdida del lenguaje a consecuencia de un daño del tejido cerebral que limita o impide la comunicación.

Disfasia: “una disfunción específica en el desarrollo de la expresión y/o la recepción del habla y del lenguaje, en ausencia de otras discapacidades que podrían considerarse como posibles causas...” Monfort y Juárez, (1993)

“un trastorno del lenguaje a nivel expresivo y/o receptivo, pero con ejecución normal de las otras destrezas o habilidades, especialmente, las tareas cognitivas no verbales; sin síntomas neurológicos evidentes” Love y Webb, (2006)

Trastornos de la comunicación escrita:

Cuando se habla de trastornos del lenguaje escrito se refiere a las dificultades relacionadas con procesos de lectura y/o escritura, que pueden darse por pérdida de la habilidad una vez desarrollada o por dificultades en el desarrollo de dichas habilidades.

Dislexia: Trastorno específico, estable y parcial del proceso de lectura que se manifiesta en la insuficiencia para asimilar los símbolos gráficos del lenguaje.

Disgrafía: Trastorno parcial, específico y estable del proceso de escritura que se manifiesta en la insuficiencia para asimilar y utilizar los símbolos gráficos del lenguaje.

El maltrato infantil y lenguaje

El lenguaje es un acto social que resulta de varios factores: los estímulos del medio, la inteligencia del niño/a, la afectividad o mundo emocional del niño/a (niño/a no atendido, rechazado). Por eso cualquier interferencia en este campo le causaría daño.

Según lo señalado en la Guía de actuaciones educativas en el ámbito de la comunicación y el Lenguaje, de Acosta y Moreno (2007), existen diversas dificultades en el Lenguaje debido a la naturaleza ambiental, tales como:

- Abuso de sustancias por parte de la madre.
- Negligencias: Abandono o descuido en nutrición, vestimenta, higiene o salud.
- Maltrato: Físico, Sexual y Emocional (No ofrecer experiencias de la vida normal, incluye atención y afecto).

Además, se puede ver por causa de varias manifestaciones tales como; mutismo y trastornos en la fluidez del habla, existiendo algunos factores que alteran los niveles del lenguaje.

Dificultades en los niveles del lenguaje

- Fonología: similar a la de sus pares o iguales.
- Morfosintaxis: oraciones simples; poca presencia de oraciones complejas.
- Semántica: vocabulario expresivo muy limitado. Pocas oraciones descontextualizadas, habla más sobre el aquí y el ahora.
- Comprensión: vocabulario receptivo similar a sus pares. Problemas en la discriminación y el procesamiento auditivo. Problemas Comprensión Lectora.
- Pragmática: habilidades conversacionales muy pobres. Dificultad para hablar acerca de sentimientos. Escaso uso de oraciones para describir. Uso del lenguaje relacionado con cosas y objetos con insuficientes intercambios sociales y afectivos.

Es fundamental señalar que el lenguaje es esencial en nuestra vida, y la violencia hacia los niños y niñas influye negativamente a este, logrando no solo una disminución en el desarrollo del lenguaje sino también afectaciones futuras como, por ejemplo, en el área académica y social.

La familia, la escuela y la comunidad participan activamente en el proceso de prevención del maltrato infantil, sin estos agentes sería imposible el desarrollo íntegro de los educandos que reciben una educación especial y que presentan trastornos en el lenguaje.

CAPÍTULO II: ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN LAS FAMILIAS DE EDUCANDOS CON TRASTORNOS EN EL LENGUAJE

En este capítulo se realiza la operacionalización de la variable, el análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos, se fundamenta la propuesta de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje que cursan el 4to año de vida en la Escuela Especial para niños y niñas con trastornos de la comunicación y el lenguaje: “Miguel Basilio Díaz Santamaría”.

2.1 Operacionalización de la variable de la investigación. Análisis del diagnóstico inicial

Las consideraciones en torno a la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje permitieron determinar la importancia que tiene la familia para el desarrollo integral de los niños y niñas en el contexto de la educación especial.

Después de analizar los referentes teóricos- metodológicos, así como los resultados de la constatación inicial, permitieron determinar como **variable de la investigación**: *la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil de educandos con trastornos en el lenguaje* que se define como: *un conjunto de acciones logopédicas con una influencia socioeducativa encaminada a elevar la percepción de riesgo de la familia con relación al maltrato infantil, encaminadas a prevenir o modificar modos de actuación, que favorezcan el desarrollo integral del estudiantado con trastornos del lenguaje y la armonía familiar.*

Con el objetivo de guiar el proceso de diagnóstico se determinaron los indicadores y descriptores de medida, en correspondencia con el problema científico asumido.

Indicadores	Descriptores de medida
Nivel de conocimiento de las familias sobre los derechos del niño y cómo prever el maltrato infantil	Alto: cuando consideran que la prevención debe ser siempre Medio: cuando consideran que la prevención debe ser en algunos momentos Bajo: cuando consideran que la prevención no se puede prever
Nivel de dominio de los tipos de maltrato que puede afectar a su hijo/a	Alto: cuando tienen conocimientos acerca de los tipos de maltrato infantil. Medio: cuando tienen muy poca información sobre los tipos de maltrato infantil Bajo: cuando no tienen conocimiento de los tipos de maltrato infantil.
Nivel de conocimiento del trastorno en el lenguaje que presenta su hijo/a	Alto: cuando tienen conocimiento sobre el trastorno en el lenguaje que presenta su hijo Medio: cuando tienen muy poco conocimiento sobre el trastorno en el lenguaje que presenta su hijo

	Bajo: cuando no tienen conocimiento del trastorno en el lenguaje que tiene su hijo
Comprensión de la necesidad de la orientación familiar para prevenir el maltrato infantil	Muy necesaria: cuando se considera importante durante toda la vida. Necesaria: se considera importante a determinadas edades o situaciones. Poco necesario: se considera que debe ser espontánea, como condición propia de la naturaleza humana

2.2 Caracterización del estado inicial

El grupo de estudio fue seleccionado de la Escuela Especial para niños/as con trastornos de la comunicación y el lenguaje: "Miguel Basilio Díaz Santamaría ubicada en el Municipio Cerro, en el centro se encuentran educandos desde 4to año de vida hasta 2do grado, con un total de 131 educandos (21 féminas y 110 varones); 85 continuantes y 46 nuevo ingreso. En lo que respecta a la comunicación oral, nivel lenguaje (retraso del lenguaje) hay 118 con esta dificultad, en el nivel habla, 9 con dislalia, 2 rinolalia y 2 con disartria.

Se escoge la muestra de forma intencional y sus características se relacionan a continuación. De las 9 familias de los educandos que presentan retraso del lenguaje según el tipo de familia nuclear biparental son 3, nuclear monoparental 5 y extensa 1, el nivel de escolaridad es superior en el 40%, medio superior un 45 % y técnico medio un 15% de las familias, tienen conocimiento del trastorno 5 de ellas y 4 no, todas son potenciadoras del desarrollo de sus hijos.

Constituye otro grupo de estudio los 9 educandos de 4to año de vida que presentan un diagnóstico de retraso del lenguaje, edades comprendidas entre los 3 y 4 años, de ellos 1 fémina y 8 varones. Presentan dificultades en el lenguaje los 9 educandos con un trastorno del nivel comunicativo lenguaje, retraso simple del lenguaje, en 5 de ellos está asociado a una infra-estimulación del lenguaje, mientras que hay 4 que presentan problemas afectivos-relacionales. El ritmo de aprendizaje es más lento en 3 educandos, los cuales requieren de reforzamiento de la base orientadora.

También conforman el grupo de estudio 8 logopedas con un aproximado entre 3 y 7 años de trabajo con los niños y niñas con trastornos de la comunicación y el lenguaje de la Escuela Especial “Miguel Basilio Díaz Santamaría”, tienen la categoría de Licenciados en Educación Logopedia. Las docentes seleccionadas obtienen resultados satisfactorios en sus evaluaciones profesoriales y disposición para formar parte de la investigación.

2.2.1 Valoración de los resultados del estado inicial de la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje

A continuación, se exponen los resultados del estado inicial de la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje, sobre la base de la escala valorativa de los indicadores.

Encuesta a los logopedas

La encuesta a las logopedas se aplicó con el objetivo de identificar las necesidades y fortalezas del profesorado en relación con la prevención del maltrato infantil. **(Anexo 1)**

Se entrevistaron a 8 maestras logopedas, son licenciados en educación y tienen un aproximado de 3 y 7 años de trabajo con los niños y niñas con trastornos de la comunicación y el lenguaje en la Escuela Especial “Miguel Basilio”.

En cuanto al indicador referido al nivel de conocimiento de las familias sobre los derechos del niño y cómo prever el maltrato infantil fue evaluado de alto para un 40% del profesorado, medio para un 30% y bajo para un 30%, mientras que el indicador referido al nivel de dominio de los tipos de maltrato que puede afectar a su hijo/a fue evaluado de alto para un 50%, medio para un 40% y bajo para un 10%.

El nivel de conocimiento del trastorno en el lenguaje que presenta su hijo/a fue evaluado de alto para un 50% y bajo para un 50% del profesorado.

En cuanto a la comprensión de la necesidad de la orientación familiar para prevenir el maltrato infantil fue evaluado de muy necesaria un 90% y de poco necesaria para un 10% del profesorado.

Se pudo constatar de modo general por parte del profesorado que, aunque reconocen la importancia de la prevención el maltrato infantil en los educandos con trastornos en el lenguaje, aún no cuentan con las herramientas y conocimientos necesarios para orientar a la familia de estos educandos.

Entrevista a la directora y jefa de ciclo

La entrevista a los directivos se aplicó con el objetivo de indagar sobre cómo se concibe la orientación familiar dirigida a la prevención del maltrato infantil. **(Anexo 2)** Se entrevistan a la directora y a la jefa de ciclo, de ellas una es máster y una licenciada, tienen un promedio de 30 años de experiencia.

Con respecto al indicador referido al nivel de conocimiento de las familias sobre los derechos del niño y cómo prever el maltrato infantil fue evaluado de alto para un 60%, medio para un 10% y bajo para un 30% de los directivos, mientras que el indicador referido al nivel de dominio de los tipos de maltrato que puede afectar a su hijo/a fue evaluado de alto para un 80% y bajo para un 20%.

El nivel de conocimiento del trastorno en el lenguaje que presenta su hijo/a fue evaluado de alto para un 50%, medio para un 40% bajo para un 10% de los directivos.

En cuanto a la comprensión de la necesidad de la orientación familiar para prevenir el maltrato infantil fue evaluado de muy necesaria un 100%.

Encuesta a la familia

La encuesta a la familia se aplicó con el objetivo de identificar las necesidades y fortalezas de la familia en relación con la prevención del maltrato infantil. **(Anexo 3)** Esta fue aplicada a 9 familias de la Escuela Especial “Miguel Basilio Díaz Santamaría”.

En cuanto al indicador referido al nivel de conocimiento de las familias sobre los derechos del niño y cómo prever el maltrato infantil fue evaluado de alto para un 30% de los docentes, medio para un 50% y bajo para un 20%, mientras que el indicador referido al nivel de dominio de los tipos de maltrato que puede afectar a su hijo/a fue evaluado de alto por el 35% de las familias, de medio por el 45% y de bajo por el 20% de las familias.

En cuanto al nivel de conocimiento del trastorno en el lenguaje que presenta su hijo/a fue evaluado de alto para un 5%, de medio por el 80% y bajo por el 15 % de las familias.

En cuanto a la comprensión de la necesidad de la orientación familiar para prevenir el maltrato infantil fue evaluado de muy necesaria para un 20%, necesaria 60% y poco necesaria para un 20% de las familias, que coinciden que, si han recibido orientación para enfrentar la educación de su hijo/a, pero muy escasa, sobre cómo hablarles, cómo lograr establecer normas de comportamientos y de conductas y de cómo lograr un mejor vínculo con sus hijos.

Se pudo constatar a modo general por parte de la familia que no tienen suficientes conocimientos sobre cómo prever el maltrato infantil y desarrollar el lenguaje de sus hijo/a, sin embargo, reconocen estar motivados para ayudar en esta labor junto a la escuela, reconocen el trastorno que presenta su hijo/a, aunque no tienen las herramientas y recursos necesarios para ayudar a prevenir el maltrato infantil en su hijo/a que presenta un trastorno del lenguaje.

Guía de observación para las reuniones de padres

Fue aplicada la guía de observación en las reuniones de padres de los educandos de 4to año de vida, con el objetivo de constatar mediante las reuniones de padres cómo se realiza la orientación familiar dirigida a la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje. **(Anexo 4)**

Como resultado se evaluó de mal el aspecto relacionado con las acciones dirigidas a orientar a la familia para prever el maltrato infantil, las educadoras no tratan ese tema en las reuniones de padres. Se evidenció gran preocupación por las inquietudes y dudas de la familia de forma general, por tanto, este aspecto fue evaluado de bien. Se observó en estas reuniones la distribución de un manual para orientar a las familias con ejercicios pre-articulatorios que pueden hacer con su hijo/a en casa, este aspecto fue evaluado de bien. Se evidenció buenas relaciones maestro-familia, tratándose con respeto y cariño, este aspecto fue evaluado de bien.

Guía para la revisión de los expedientes logopédicos

La guía para la revisión de los expedientes logopédicos se aplicó con el objetivo de identificar las acciones dirigidas a la orientación familiar del estudiantado con

trastornos en el lenguaje y constatar si se reflejan aspectos relacionados con el maltrato infantil. **(Anexo 5)**

Se revisaron los expedientes logopédicos del grupo de estudio y se pudo constatar que en función del diagnóstico no se realizan acciones para la prevención del maltrato infantil y no se orientan actividades a desarrollar en el marco familiar.

Exploración logopédica

La exploración logopédica a los educandos investigados **(Anexo 6)** reveló las regularidades siguientes: De los 9 educandos el 100% presenta un trastorno de la comunicación oral, nivel comunicativo lenguaje, retraso del lenguaje; debido a una pobre estimulación en la edad temprana. Entre los sonidos más afectados se encuentran /s/, /r/, /t/, /d/, /f/, /l/, /b/, /g/, /n/, /k/, /sdd/.

El análisis de los resultados de los diferentes instrumentos utilizados permitió identificar las siguientes fortalezas y debilidades de las dimensiones antes declaradas.

Fortalezas

- Se ha trabajado teóricamente el contenido del maltrato infantil.
- Se comprobó que en situaciones de maltrato infantil de familiares con sus hijos/as la escuela se ha hecho cargo y lo han denunciado

Debilidades

- No se realizan en la escuela suficientes acciones dirigidas a la prevención del maltrato infantil.
- No es suficiente la preparación que ha recibido el claustro de profesores sobre la prevención del maltrato infantil.
- Es insuficiente el trabajo del logopeda con relación a la orientación familiar para prevención del maltrato infantil.
- Escasos materiales didácticos en el gabinete logopédico para trabajar la prevención de la violencia y maltrato infantil.

2.3 Fundamentación, estructura y funcionamiento de la propuesta de folleto de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje

El análisis bibliográfico realizado por la autora y los resultados de los diferentes instrumentos aplicados permitieron que se proponga como posible solución al problema de investigación un folleto de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje. **(Anexo 7)**

En este sentido es conveniente analizar el significado de Folleto que según el Diccionario ARISTOS, (1985) "...es obra impresa de poca extensión". Esta fuente es abordada por otros autores que en sus investigaciones utilizan folletos como vía para divulgar los resultados de su investigación Travieso, E. (2008); Fresquet, M. (2015). Además, se han consultado otros sitios que explican de modo general las particularidades de este tipo de material (<https://es.wikipedia.org>), las que permitieron realizar una aproximación a su definición y características en correspondencia con el contexto educativo y tema de la presente investigación.

Se asume que un folleto es un documento impreso en papel que tiene como objetivo divulgar o publicitar cierta información. Es decir, los folletos son herramientas que permiten enseñar y transmitir datos específicos.

Se diferencian de los libros por varias razones: en primer lugar, los folletos son de extensión breve, por lo que solo pueden alcanzar un máximo de 24 hojas. Así mismo, los folletos presentan la información de forma resumida y fácil de entender para la mayoría del público.

Los folletos suelen ser muy llamativos, puesto que usan títulos muy atractivos e imágenes o fotografías. Además, no solo se utilizan para publicitar un producto; también son empleados en las escuelas, las universidades y otras instituciones con la finalidad de instruir a un grupo específico de personas.

Fundamentos de la propuesta

El folleto de orientación familiar se fundamenta en la teoría de la actividad dialéctico materialista, que permite comprender el surgimiento y desarrollo de la conciencia y el lenguaje, estudiar la comunicación como resultado del desarrollo de la actividad espiritual en la que se establece la interrelación entre el conocimiento, la valoración y la comunicación.

En el folleto se asume al hombre como una entidad biológica, psíquica, individual, social e histórico- concreta puesto que este a partir de las condiciones biológicas que

posee y los procesos de estimulación de que es objeto mediante la actividad y la comunicación permite ser protagonista de su desarrollo y con ello favorece su formación integral al transformarlo con un gran sentido de solidaridad humana, se reconoce el papel condicionante de los factores biológicos en el desarrollo de la comunicación oral y escrita de los educandos con trastornos del lenguaje.

La propuesta se sustenta en los principales postulados de la escuela histórico- cultural de Vigotski L.S y sus seguidores (1989) pues es un folleto donde se brindan orientaciones a la familia dirigida a lograr una adecuada armonía en el sistema de influencias educativas provenientes del medio escolar y familiar, tiene en cuenta la mediación del docente y otros agentes de socialización, así como la categoría “otros” y la unidad de lo afectivo y lo cognitivo.

El folleto se desarrolla con un enfoque preventivo, correctivo-compensatorio y se sustenta en la educación de la personalidad con lo más elevado del pensamiento pedagógico cubano y los resultados de investigaciones que asumen los principios pedagógicos expuestos por Addine, F. González, A. Recarey, S. (2002) donde se establece la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, al favorecer los intereses de la familia y elevar el nivel de exigencia de los educandos mediante su valor práctico e individual, así como el principio del carácter colectivo e individual de la educación y respeto a la personalidad, porque las acciones están desarrolladas en correspondencia con las características del educando objeto de estudio, al cual está dirigido, en él se evidencia la triada escuela, familia y comunidad como enfoque de integración social al prevalecer la intención educativa y transformadora de las acciones dirigidas a propiciar mejor calidad de vida y educación a los educandos con trastornos del lenguaje.

En el folleto se asumen los principios didácticos expuestos por Silvestre, M. (2002) para un Proceso de Enseñanza Aprendizaje desarrollador entre ellos el carácter educativo de la enseñanza que expresa la unidad de la instrucción y la educación al orientar a la familia para la prevención del maltrato infantil para su hijo/a que presenta un trastorno en el lenguaje mediante un folleto de orientación familiar, cumple con el principio de la asequibilidad, pues para su elaboración se desarrolló un diagnóstico a los educandos y a la familia para conocer las regularidades del desarrollo y a partir

de sus necesidades y potencialidades elaborar las acciones y actividades con un lenguaje claro, preciso y comprensible, mediado por la actividad y la comunicación.

Las acciones y actividades del folleto están en correspondencia con las particularidades de los niños/as que se encuentran en la primera infancia y presentan un trastorno en el lenguaje.

Características del folleto de orientación familiar

El folleto de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje, partió de la necesidad de orientar a la familia de estos niños y niñas que presentan dificultades en la comunicación, que en muchas ocasiones no saben cómo realizar ciertas actividades con sus hijos sin acudir al regaño o incluso a los golpes, ya sea por poca paciencia o escasa información del tema. Se debe utilizar principalmente en las reuniones de padres, momento propicio para el trabajo de orientación familiar. En el folleto de manera práctica y sencilla se ofrecen explicaciones sobre la importancia de una buena comunicación y las diferentes maneras de potenciar el desarrollo lingüístico sin recurrir al maltrato. El lenguaje utilizado en el folleto resulta de fácil comprensión para cualquier miembro de la familia.

Estructura de la propuesta

La estructura de la propuesta se fundamenta en los referentes teóricos abordados en el capítulo 1, en el diagnóstico del estado actual y en los fundamentos tratados con anterioridad.

Título del folleto: “Sin maltrato se educa mejor”

Objetivo: Orientar a las familias para la prevención del maltrato infantil en escolares con trastornos en el lenguaje.

El folleto consta de: introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. En la **introducción** se hacen aclaraciones generales y aparecen algunos contenidos teóricos que facilitarán la comprensión del folleto como definiciones de maltrato infantil y trastornos del lenguaje, y la importancia de la primera infancia.

En el **desarrollo**, aparecen sugerencias concretas para facilitar la comunicación asertiva con un niño o niña que presenta algún trastorno en el lenguaje, pero libre de violencia. Estas sugerencias se desarrollan mediante los siguientes temas:

- ¡Lee con atención!
- Los niños/as tienen derechos
- Ejercicios con amor
- Autoestima
- Educar sin gritar
- Jugando en familia
- Confinados en armonía
- Pedir ayuda

En las **conclusiones** del folleto se explica algunos últimos consejos para que pongan en práctica con su hijo/a, la importancia del trabajo complementario de la escuela y la familia para prevenir todos los tipos de maltrato infantil que puede sufrir el niño/a con trastorno en el lenguaje.

En la **bibliografía** se precisa los autores y libros consultados para la confección del folleto.

2.4 Valoración de los resultados de la consulta de especialista

El proceso de valoración del folleto de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje se realizó mediante la consulta a especialistas.

Para la consulta a especialistas (**Anexo 8**) se requirió la emisión del juicio valorativo de un grupo de 10 especialistas, todos de reconocido prestigio y calidad en su desempeño profesional. La selección se desarrolló de forma intencional. Dicho grupo estuvo compuesto por 5 doctores y 5 licenciados entre 1 y 40 años de experiencia. Se le entregó un cuestionario con una escala valorativa.

Los resultados fueron los siguientes:

Relacionado con la **estructura**, el 100% de los especialistas consideró la propuesta de muy adecuada, plantearon que se tiene en cuenta la lógica del proceso, así como la relación dialéctica de sus componentes.

El 100% consideró la propuesta de muy adecuada pues se **ajusta a las particularidades de los niños/as de la primera infancia.**

El 80% la evaluó de muy adecuada y el otro 20% de adecuada los **contenidos relacionados con el lenguaje.**

En cuanto a la **evidencia de la prevención del maltrato infantil**, el 90% la evaluó de muy adecuada y el 10% de adecuada.

Como sugerencias propusieron revelar, aún más, en las actividades propuestas la atención y estimulación al área del lenguaje. Utilizar un lenguaje más asequible para la familia; lograr una mejor integración entre el desarrollo del lenguaje y la prevención del maltrato infantil; además seguir profundizando sobre el tema y aplicar la propuesta del folleto en la práctica pedagógica. La valoración realizada por los especialistas evidencia su aplicabilidad y posible efectividad.

CONCLUSIONES

El estudio de los referentes teóricos-metodológicos que sustentan la orientación familiar están basados en una relación de ayuda que les permita conducir el proceso de prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje.

El diagnóstico del estado inicial del problema que se investiga reveló que existen insuficiencias en la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en los educandos que presentan trastornos en el lenguaje.

El folleto de orientación familiar constituye una herramienta que orienta a la familia en la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje. Ofrece una información valiosa que los prepara para prever cualquier tipo de maltrato infantil y a su vez desarrollar el lenguaje de su hijo/a.

RECOMENDACIONES

- Profundizar en los contenidos teórico-metodológicos relacionados con la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje.
- Aplicar el folleto de orientación familiar en la práctica pedagógica.
- Divulgar el resultado del folleto de orientación familiar en eventos científicos y otros espacios de intercambio y socialización.
- Emplear los resultados de esta investigación como material de consulta por el profesorado y estudiantado de las carreras Educación Logopedia y Especial con vista al perfeccionamiento de su formación .

BIBLIOGRAFÍA

- 1- Acosta, V. & Moreno, A. (2007). *Guía de actuaciones educativas en el ámbito de la comunicación y el lenguaje*. Gobierno de Canarias, España: CANARICARD
- 2- Arés, P. (2000). *La familia. Una mirada al futuro*. Conferencia Magistral. Taller Internacional "Abriendo las puertas de la familia", La Habana, Cuba.
- 3- Bernal, R.E. (2010). *Estrategia Educativa para la prevención del maltrato infantil en las familias de escolares con retraso mental*. Tesis de doctorado. La Habana, Cuba: Facultad de Educación Infantil. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
- 4- Blanco, A. (2000). *Introducción a la sociología de la Educación* ISPEJV. Replicación C.D, Versión I. Carrera Educación Especial. La Habana, Cuba.
- 5- Castro, A. (1996). *¿Cómo la familia cumple su función educativa?* Editorial. Pueblo y Educación, La Habana, Cuba.
- 6- Castro P. L; Castillo S, (2000). *Para conocer mejor a la familia*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. (p. 9)
- 7- CEPAL (2016). Agenda Universal 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago: <http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf>
Consultado 5 de junio del 2019
- 8- Colectivo de autores, Logopedia Primera Parte. Textos para los estudiantes de las carreras Licenciatura en Logopedia y Educación Especial, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba, 2012.
- 9- Colectivo de Autores, Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba, 2012.
- 10-Colectivo de Autores. *Educa a tu hijo. La experiencia cubana en la atención integral al desarrollo infantil en edades tempranas*. MINED. Habana. 2003.
- 11- CUBA, Constitución de la República de Cuba (2019). Editorial Pueblo y Educación.
- 12-Durán, A. (2005). *Convivir en Familias sin Violencia*, Ed. Imágenes, Ciudad de la Habana.

- 13-El Malouf, S. (2009). *Consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo del lenguaje y en la conducta social de los niños*. Ecuador
- 14-Fernández Pérez de Alejo, G., M. Pons Rodríguez, M. Carreras Morales y X. Rodríguez Fleitas (2013) Logopedia. Segunda parte. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
- 15-Hernández, D. (2018). *La orientación familiar en la corrección de la dislalia mediante la tarea para la casa*. Trabajo de diploma. La Habana, Cuba: Facultad de Educación Infantil. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
- 16-Lammoglia, E. (1999). *Abuso Sexual en la Infancia, Como Prevenirlo y Superarlo*. Ed. Grijalbo, S.A, México.
- 17-Larraín, S. y Bascuñan, C. (2012) Cuarto Estudio de Maltrato Infantil. Chile. UNICEF
- 18-Organización Mundial de la Salud (2003). Informe mundial sobre la violencia y la salud. http://www.paho.org/spanish/am/pub/violencia_2003.htm
Consultado 23 de abril del 2019
- 19- Organización de Naciones Unidas (2006). *La violencia contra niños, niñas y adolescentes*. Informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial de las Naciones Unidas 2006. Disponible en: http://www.crin.org/docs/UNVAC_Estudio_violencia_LA.pdf
Consultado 6 de diciembre del 2020.
- 20- Organización Panamericana de la Salud (s.f.). *Maltrato infantil y abuso sexual en la niñez*. Disponible en: www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/si-maltrato1.pdf
Consultado 5 de mayo del 2019.
- 21- Pinheiro, C. (2006). *Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas*. Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas. Disponible en: www.unicef.org/lac.
Consultado 20 de septiembre de 2020.
- 22-Tellería, D. (2018). *Talleres para la educación de la sexualidad, con enfoque de género, en educandos con discapacidad intelectual*. Trabajo de diploma. La Habana, Cuba: Facultad de Educación Infantil. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.
- 23- Torres, M. (2003). *Familia, Unidad y Diversidad*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

24-Unicef.org. (2021). *Cada niño está protegido de la violencia y la explotación.*

Disponible en: <https://www.unicef.org/cuba/cada-nino-esta-prottegido-violencia-explotacion>

Consultado 8 de marzo 2021

25- Zarama, M^a E. (1998). *Maltrato Infantil. Prevención y Atención; Campaña por el buen Trato. Memorias del Congreso de Prevención y Atención del Maltrato Infantil.* Bogotá.

ANEXO 1: Encuesta a los logopedas de la Escuela Especial para niños y niñas con trastornos de la comunicación y el lenguaje: “Miguel Basilio Díaz Santamaría”.

Objetivo: identificar las necesidades y fortalezas del profesorado en relación con la prevención del maltrato infantil.

Estimado educador:

Nos encontramos realizando esta encuesta para conocer el trabajo de los educadores en la prevención del maltrato infantil. Sería de gran utilidad que usted nos responda con sinceridad y gracias por su colaboración.

Años de experiencia laboral: ----- Sexo: -----

1- Ha recibido preparación sobre:

	Recientemente	Hace mucho	Nunca
Dinámica de grupos			
Tratamiento sobre violencia			
Prevención del maltrato infantil			
Educación por la paz			
Derechos del niño/a			

2- Completa la siguiente frase:

Maltrato infantil es:

3- De las siguientes opciones marque con una x ¿Cuáles consideras formas de manifestación de maltrato infantil?

	Si	No
Amenaza		
Agresión física		
Riñas familiares		

Sobreprotección		
Infra estimulación		
Abuso sexual		
Ridiculizar a alguien		
Prohibir jugar con otros niños/as		
Abandono		
Otras ¿Cuáles?		

- 4- Sobre las relaciones con las familias de sus escolares marque con una x la frecuencia.

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
Se muestra afectuoso/a en las relaciones que mantienen con las familias de sus educandos.					
Tiene en cuenta las opiniones de las familias de sus escolares en las actividades que realizan en la escuela.					
Desarrolla alternativas para que las familias de sus escolares solucionen los conflictos con sus hijos/as sin violencia.					

- 5- De los siguientes comportamientos. ¿Cuáles consideras factores de riesgo para la ocurrencia de maltrato infantil en las familias de sus alumnos?

	Siempre	Casi siempre	Casi Nunca	Algunas veces	Nunca
Familias monoparentales					
Presentar trastornos en el lenguaje					
Existencia de adicciones (alcoholismo, drogadicción, etc.)					
Dificultades económicas					
Bajo nivel cultural					
Historia de maltrato infantil en la familia.					
Baja autoestima					
Otras. ¿Cuáles?					

6- ¿Qué suele hacer ante la evidencia de que ha sido maltratado alguno de sus alumnos?

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
Me retiro					
Solicito ayuda					

Nada, aunque siento que debería hacer algo					
Intervengo personalmente					
No estoy preparado para actuar					

7- ¿Qué consecuencias puede tener para el desarrollo personal de sus escolares, ser víctima de maltrato infantil en el hogar?

8- ¿Cómo puede la escuela intervenir para prevenir el maltrato infantil en las familias de sus alumnos?

ANEXO 2: Entrevista a la directora y jefa de ciclo de la Escuela Especial para niños y niñas con trastornos de la comunicación y el lenguaje: “Miguel Basilio Díaz Santamaría”.

Objetivo: indagar sobre cómo se concibe la orientación familiar dirigida a la prevención del maltrato infantil.

Estimado directivo: se está desarrollando una investigación acerca de la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje. Es necesario que conteste las siguientes preguntas:

Es U.D. licenciado: _____ estudia maestría: _____ es máster: _____

Años de experiencia como docente: _____

Años de experiencia con el cargo: _____

- 1- ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo?
- 2- ¿Sobre qué temáticas relacionadas con la educación para la salud usted ha recibido preparación?
- 3- ¿De las temáticas de la educación para la salud cuáles son las que se le da prioridad?
- 4- ¿Cómo desde el trabajo metodológico en la escuela se les da prioridad?
- 5- ¿Cómo se ha trabajado la prevención del maltrato infantil?
- 6- ¿Qué manifestaciones de maltrato entre los niños y niñas los maestros han identificado? ¿Han identificado situaciones de violencia entre los profesores-profesores, profesores-alumnos?
- 7- ¿Cómo se trabaja en la escuela la orientación a la familia?
- 8- ¿Con qué materiales cuenta la escuela para trabajar la educación para la salud?

ANEXO 3: Encuesta a los familiares de los educandos de 4to año de vida de la Escuela Especial para niños y niñas con trastornos de la comunicación y el lenguaje: “Miguel Basilio Díaz Santamaría”.

Objetivo: identificar las necesidades y fortalezas de la familia en relación con la prevención del maltrato infantil.

Estimada familia:

La presente encuesta constituye un elemento importante de una investigación que se realiza en la escuela de su hijo/a para lograr una mejor orientación a las familias sobre su educación. Solicitamos su colaboración con la realización de esta encuesta.

Familiar que llena la encuesta _____

Edad _____ Escolaridad _____

Grado que cursa el educando _____ Edad _____ Sexo _____

1- Trabaja el padre SI _____ NO _____

Centro de trabajo _____

Vive con el alumno SI _____ NO _____ (en caso de No ¿Por qué?)

-Trabaja la madre SI _____ NO _____

Centro de Trabajo _____

Vive con el alumno SI _____ NO _____ ¿Por qué? _____

2- Se siente preparado para enfrentar la educación de sus hijo/a SI _____ NO _____

¿Por qué? _____

-Ha recibido alguna orientación por parte de la escuela para enfrentar la educación de su hijo/a

SI _____ NO _____

¿Cuál? _____

3- Identifique de los siguientes elementos. ¿Cuáles son derechos de sus hijos/as?

_ A la vida.

_ A la educación.

_ A la salud.

_ A la participación.

_ A la información.

☐ A la protección.

☐ A la atención diferenciada.

☐ A la inclusión social.

4- Hay conductas ante las cuales hay que tomar medidas. Marque con una x las que ha tenido que tomar ante determinadas situaciones.

☐ Golpes ☐ Gritos ☐ Amenaza ☐ Crítica ☐ Penitencia ☐ Dejo sin comer ☐
☐ Consejo ☐ Otras ¿Cuáles?

5- Marque con una x las opciones que considere correctas.

Tener un hijo/a con algún trastorno en el lenguaje implica:

☐ No es necesario atender sus demandas.

☐ No es necesario un horario de vida.

☐ Necesita mucha atención por parte de la familia.

☐ No necesita conocer sobre sexualidad.

☐ Puede estar mucho tiempo solo.

6- ¿Cuándo un niño/a es maltratado?

a) ¿Qué situaciones pueden llevar a una familia a maltratar a sus hijos/as?

7- Marque con una x según corresponda la situación.

Sobre mi hijo/a	Siempre	Casi siempre	A veces	Casi nunca	Nunca
Le demuestro el amor que siento por él.					
Comparto con él o ella durante el tiempo libre.					
Lo apoyo durante la realización de las tareas.					
Tengo en cuenta sus opiniones					
Participa en las tareas del hogar.					
Le permito jugar con los amigos del barrio					

8-Sobre qué aspectos considera que necesita orientación para mejorar la educación de su hijo/a.

ANEXO 4: Guía de observación para las reuniones de padres de los educandos de 4to año de vida.

Objetivo: constatar mediante las reuniones de padres cómo se realiza la orientación familiar dirigida a la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos del lenguaje.

La presente guía se utilizará para el diagnóstico del estado inicial de la orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje. En la presente guía se tuvo en cuenta los indicadores que la autora asume.

Aspectos	B	R	M
Acciones dirigidas a orientar a la familia para prevenir el maltrato infantil			
Preguntas a la familia sobre sus inquietudes y dudas			
Distribución de algún material sobre los trastornos en el lenguaje			
Relaciones maestro-familia			

ANEXO 5: Guía en la revisión de los expedientes logopédicos:

Se revisarán los expedientes logopédicos del grupo de estudio con el **objetivo** de identificar las acciones dirigidas a la orientación familiar del estudiantado con trastornos en el lenguaje y constatar si se reflejan aspectos relacionados con el maltrato infantil, de los expedientes se tendrán en cuenta los siguientes datos:

Aparecen actividades a desarrollar en el marco familiar para la prevención del maltrato infantil.

Sí----- No ----- Algunas-----

Se conciben acciones para prevenir el maltrato infantil.

Sí----- No ----- Algunas-----

ANEXO 6: Exploración logopédica a los educandos de 4to año de vida de la Escuela Especial para niños y niñas con trastornos de la comunicación y el lenguaje: “Miguel Basilio Díaz Santamaría”.

Objetivo: diagnosticar el trastorno de la comunicación y el lenguaje que presentan los educandos de 4to año de vida.

HOJA DE EXPLORACIÓN DEL LENGUAJE

Centro				
Nombres y apellidos				Expediente CDO
Fecha de nacimiento	Edad	Sexo	Grado	Cursos de repitencia
Procedencia del niño				
Motivo de consulta				

Datos concretos sobre la evolución del lenguaje

Otros datos de interés

Examen específico del habla. Estado del aparato articulatorio

Características de la audición
Estado de la expresión oral. Conversación espontánea. Características

Vocabulario (volumen, calidad, significado)																																																																																																																																																																																																																
Estructura gramatical (análisis de las características morfológicas)																																																																																																																																																																																																																
Análisis de la pronunciación y de los procesos fonemáticos <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>fonema</th><th>I</th><th>M</th><th>F</th> <th>fonema</th><th>I</th><th>M</th><th>F</th> <th>fonema</th><th>I</th><th>M</th><th>F</th> <th>fonema</th><th>I</th><th>M</th><th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a</td><td></td><td></td><td></td><td>k</td><td></td><td></td><td></td><td>FL</td><td></td><td></td><td></td><td>ei</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>e</td><td></td><td></td><td></td><td>g</td><td></td><td></td><td></td><td>GL</td><td></td><td></td><td></td><td>eu</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>o</td><td></td><td></td><td></td><td>j</td><td></td><td></td><td></td><td>CL</td><td></td><td></td><td></td><td>oi</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>i</td><td></td><td></td><td></td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td>BR</td><td></td><td></td><td></td><td>ou</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>u</td><td></td><td></td><td></td><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td>PR</td><td></td><td></td><td></td><td>ia</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>m</td><td></td><td></td><td></td><td>n</td><td></td><td></td><td></td><td>FR</td><td></td><td></td><td></td><td>ie</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>p</td><td></td><td></td><td></td><td>s</td><td></td><td></td><td></td><td>DR</td><td></td><td></td><td></td><td>iu</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>b</td><td></td><td></td><td></td><td>l</td><td></td><td></td><td></td><td>TR</td><td></td><td></td><td></td><td>io</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>f</td><td></td><td></td><td></td><td>r</td><td></td><td></td><td></td><td>GR</td><td></td><td></td><td></td><td>ua</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ch</td><td></td><td></td><td></td><td>rr</td><td></td><td></td><td></td><td>CR</td><td></td><td></td><td></td><td>ue</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>y</td><td></td><td></td><td></td><td>BL</td><td></td><td></td><td></td><td>ai</td><td></td><td></td><td></td><td>ui</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ñ</td><td></td><td></td><td></td><td>PL</td><td></td><td></td><td></td><td>au</td><td></td><td></td><td></td><td>uo</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	fonema	I	M	F	fonema	I	M	F	fonema	I	M	F	fonema	I	M	F	a				k				FL				ei				e				g				GL				eu				o				j				CL				oi				i				t				BR				ou				u				d				PR				ia				m				n				FR				ie				p				s				DR				iu				b				l				TR				io				f				r				GR				ua				ch				rr				CR				ue				y				BL				ai				ui				ñ				PL				au				uo			
fonema	I	M	F	fonema	I	M	F	fonema	I	M	F	fonema	I	M	F																																																																																																																																																																																																	
a				k				FL				ei																																																																																																																																																																																																				
e				g				GL				eu																																																																																																																																																																																																				
o				j				CL				oi																																																																																																																																																																																																				
i				t				BR				ou																																																																																																																																																																																																				
u				d				PR				ia																																																																																																																																																																																																				
m				n				FR				ie																																																																																																																																																																																																				
p				s				DR				iu																																																																																																																																																																																																				
b				l				TR				io																																																																																																																																																																																																				
f				r				GR				ua																																																																																																																																																																																																				
ch				rr				CR				ue																																																																																																																																																																																																				
y				BL				ai				ui																																																																																																																																																																																																				
ñ				PL				au				uo																																																																																																																																																																																																				
Observaciones																																																																																																																																																																																																																

Ritmo y fluidez del Lenguaje

Características de la voz

Examen de la lectura y escritura

Escritura

Conducta observada durante la prueba

Diagnóstico logopédico

Recomendaciones

Observaciones:

Fecha de inicio de la atención logopédica: _____

Resultado de las evaluaciones periódicas: _____

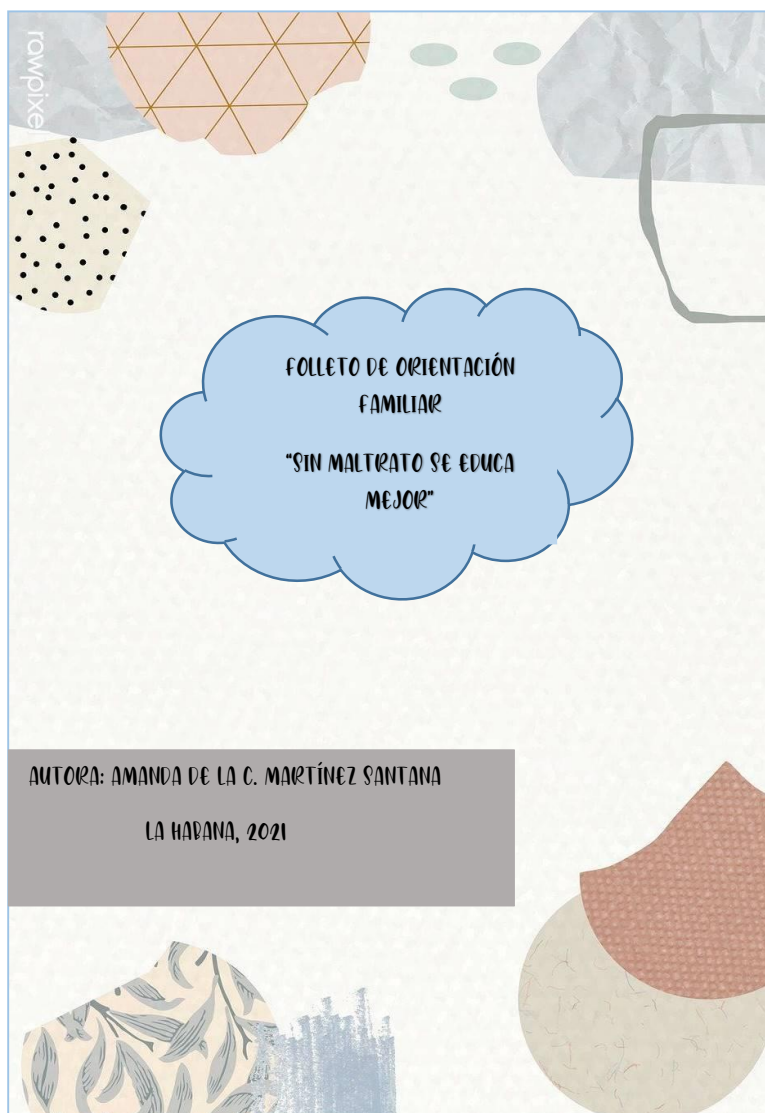
1er período: _____

2do período: _____

3er período: _____

Resultados de la atención logopédica:

ANEXO 7: Folleto de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje. (debido a su extensión se encuentra en otro documento pdf)



ANEXO 8: Guía en la consulta a especialistas

Investigación: Orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje.

Objetivo: evaluar el folleto de orientación familiar para la prevención del maltrato infantil en educandos con trastornos en el lenguaje.

Estudiante: Amanda de la Caridad Martínez Santana.

Estimado docente, a continuación, le ponemos a consideración un folleto de orientación familiar titulado: **“Sin maltrato se educa mejor”**. Le solicitamos que lo analice y valore su pertinencia a partir de los siguientes indicadores. Le agradecemos de antemano su cooperación.

Categoría científica _____ Años de experiencia _____

Indicadores en el análisis	Escala valorativa			
	MA	A	PA	NA
Estructura del folleto	10			
Ajuste de las actividades a las particularidades de los niños/as de la primera infancia	10			
Contenidos relacionados con el lenguaje	8	2		
Se evidencia la prevención del maltrato infantil	9	1		

(MA) Muy Adecuada **(A)** Adecuada **(PA)** Poco Adecuada **(NA)** No Adecuada.

¿Qué sugerencias puede dar usted al respecto?

Agradecemos todas las observaciones que realizó del folleto. Cualquier sugerencia será bien recibida para perfeccionar el folleto.